



NOMBRE DEL ESTUDIANTE 4to SEMESTRE 2025A		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE : Samuel Humberto Palacio Peña		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD:	CIRUJANO:	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO A REALIZAR: *URETEROSCOPIA FLEXIBLE CON LASER HOLMIUN*

PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

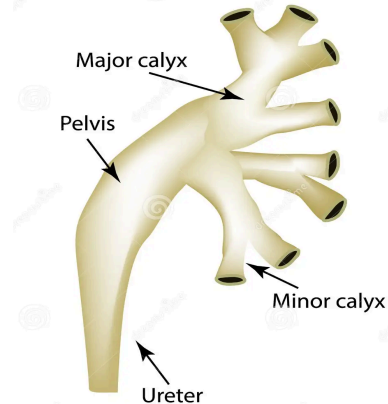
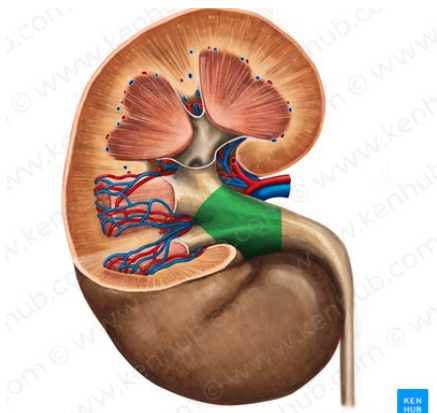
• ETAPA DE PLANEACIÓN:

1.1. Objetivo Quirúrgico: (Hacer descripción)

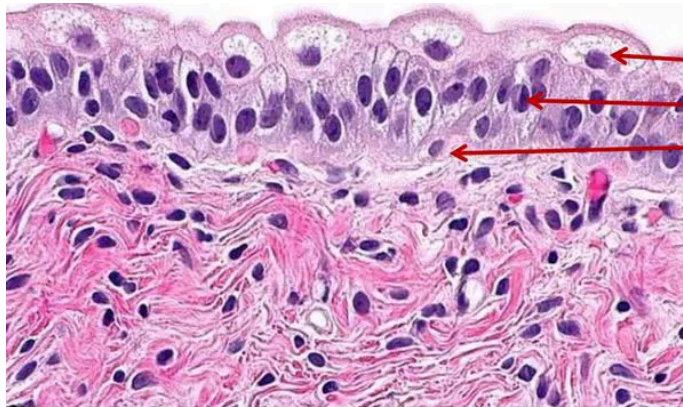
Es un procedimiento en el cual se accede al uréter y al riñón. Una vez se visualiza el cálculo se procede a desintegrarlo (destruirlo) mediante la utilización de un láser (Láser Holmium).

1.2. Anatomía y fisiología: (Hacer gráfico y descripción).

ANATOMÍA



La pelvis renal es una estructura anatómica del sistema urinario situada en el hilio del riñón, tiene forma de un embudo, con una amplia base que recibe la orina de los cálices mayores y una punta estrecha que se continúa con el uréter. Está compuesta por: cáliz mayor, cáliz menor y uréter.

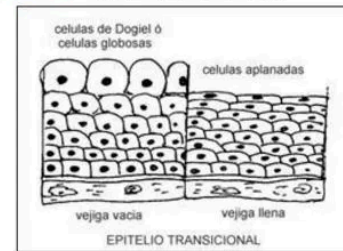


EPITELIO:

Capa superficial

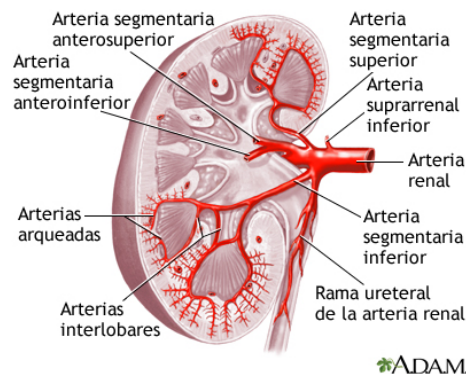
Capa celular intermedia

Capa celular basal



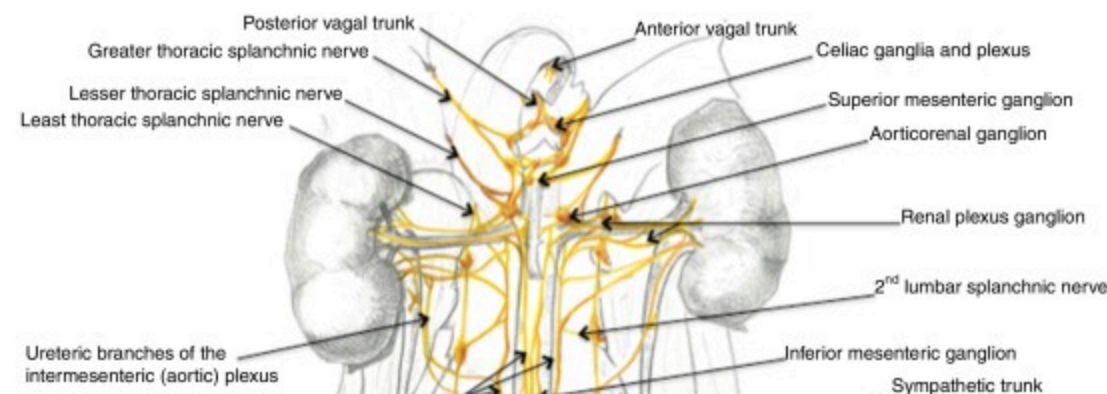
Estructuralmente está constituida por una mucosa, una túnica muscular lisa, dispuesta en una capa interna circular que ayuda en el movimiento de la orina hacia el uréter por medio de contracciones peristálticas y una capa externa longitudinal, y una adventicia. La pelvis renal está revestida por un epitelio de transición, llamado **UROTTELIO**, que es flexible y resistente a la orina.

IRRIGACIÓN



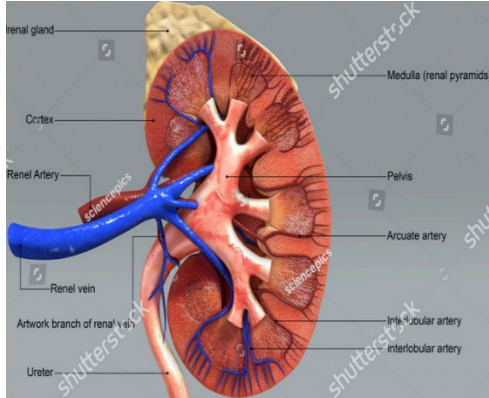
Se encuentra irrigado anteriormente por la Arteria Renal de manera posterior con la rama posterior que medialmente se prolonga hasta los vasos pre vertebrales, gonadal, ilíaca común, vesical y uterina.

INERVACIÓN



Recibe innervación parasimpática de los nervios Esplénicos Pélvicos y del plexo hipogástrico inferior.

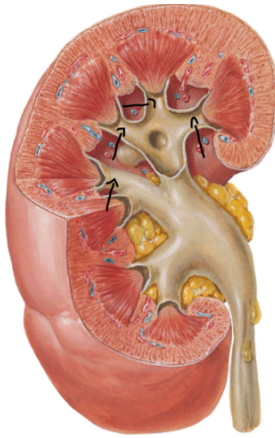
DRENAJE VENOSO



Su drenaje venoso consta de las ramas de la Vena Renal. La sangre de la pelvis renal drena hacia las venas renales, que luego desembocan en la vena cava inferior.

- Los plexos venosos de la pelvis rodean los órganos pélvicos.
- La mayoría de los plexos venosos desembocan en la vena ilíaca interna.
- La vena ilíaca interna recibe afluentes de las venas rectal media, obturatriz, sacra lateral, glútea inferior y glútea superior.

FISIOLOGÍA



Su función principal es actuar como embudo que recoge la orina producida en el riñón y la dirige hacia el uréter, desde donde se transporta a la vejiga para su almacenamiento y posterior eliminación.

- **Recogida y canalización:** La orina producida en las nefronas se recoge en los túbulos colectores y luego se drena hacia los cálices menores. Desde allí, la orina fluye hacia los cálices mayores y finalmente a la pelvis.
- **Peristalsis:** Las contracciones peristálticas del músculo liso en la pared de la pelvis renal ayudan a propulsar la orina hacia el uréter.
- **Prevención del reflujo:** La anatomía de la unión pieloureteral (donde la pelvis renal se conecta con el uréter) ayuda a prevenir el reflujo de orina hacia los riñones, lo cual es esencial para evitar infecciones y daño renal.
- **Adaptabilidad:** El urotelio tiene la capacidad de expandirse y contraerse, permitiendo a la pelvis manejar diferentes volúmenes de orina sin sufrir daño.
- **Protección Inmunológica:** La pelvis renal posee una mucosa que actúa como barrera defensiva contra patógenos y sustancias tóxicas presentes en la orina.



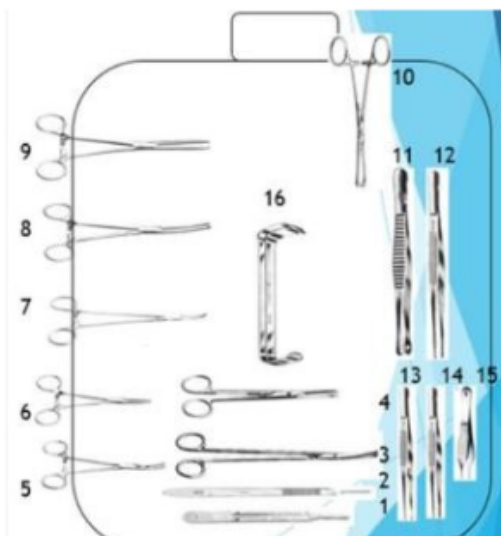
1.3. Lista de chequeo:

INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS	FÁRMACOS Y SOLUCIONES
• Lithovivue (Ureteroscopia flexible o Storz) • Torre de laparoscopia • Intensificador de imagen • Mesa radiolúcida • Cistoscopio • Canastilla • Láser Holmium • Fibras del laser	• Paquete de ropa • Guantes • Compresas • Platón • Guías de nitinol • Sondas Foley • Catéter doble J • Jeringas • Medio de contraste • Caucho de Succión • Camisa Ureteral • Fundas de Intensificador de imagen	• Piel: Polipropileno 3/0 ACC 3/8. Polidioxanona 4/0 ACC para niños. • Tejido celular subcutáneo: Poliglactin 910 3/0 ACR ½ círculo • Fascia - Músculo: Poliglactin 910 1 o 0 ACR ½ círculo • Pieloplastia: Poliglactina 910 4/0 – 5/0 ACR 1/2. Polidioxanona 4/0 – 5/0 ACR 1/2.	• Solución salina • Xilocaína de jalea • Lactato de Ringer o Glicina 10



• **ETAPA DE ORGANIZACIÓN:**

- o Arreglos de mesas de mayo y reserva (realizar esquema).



17. Mango de Bisturí 4- Hoja 20
18. Mango de Bisturí 3 Largo – Hoja 15
19. Tijeras de Metzembaum
20. Tijeras de Mayo recta
21. Pinza Kelly curva
22. Pinza Kelly recta
23. Pinza Kelly Adson
24. Pinza Rochester curva
25. Pinza Rochester recta
26. Pinza Allix
27. Pinza Disección Rusa
28. Pinza Disección sin garra larga
29. Pinza Disección con garra corta
30. Pinza Disección sin garra corta
31. Disección Adson con garra
32. Separadores de Farabeuf



1. Equipo General
2. Coca
3. Valva Maleable
4. deaver Angosto
5. Pinzas Cístico
6. Clamps de Satinsky
7. Clamps de Debakey
8. Coca con suero
9. Cánula de yankawer
10. Portaagujas
11. Suturas
12. Tijeras de Metzembaum Fina
- Larga
13. Tijeras de Mayo larga
14. Pinza de Foester
15. Pinza de campo de
- Backhouse
16. Compresa
17. Lapicero del Electrobisturí
18. Paquete de ropa
19. Guantes
20. Caucho de succión



2.2. Posición del paciente (Nombre y gráfico):



LITOTOMÍA

2.3. Ubicación del Equipo Quirúrgico (realizar gráfico):





- **ETAPA DE EJECUCIÓN:**

a) **Anestesia (escribir el tipo de anestesia):**

- Anestesia General.

b) **Incisión (escribir el tipo de abordaje y el nombre de la incisión):**

- Se realiza incisión transperitoneal

c) **Proceso Quirúrgico (Describir los pasos principales de la técnica médico-quirúrgica con el instrumental a usar).**

TÉCNICA QUIRÚRGICA

1. Uso de lidocaína (Intrauretral) Identificación de meato ureteral (Izquierdo o Derecho)
2. Paso de la guía de nitinol hasta el riñón, bajo el intensificador de imagen
3. Por medio de la guía se pasa la camisa ureteral, bajo el intensificador
4. Paso del Lithovius hasta el riñón
5. Se realiza nefroscopia
6. Identificación del cálculo
7. Paso de fibra láser (Pasa por dentro del Lithovius)
8. Evacuación de fragmentos con canastillas Colocación del cateter doble J
9. Paso de sonda Vesical (Si lo requiere)